

Neurologisches Rehabilitationszentrum Quellenhof  
Kuranlagenallee 2 | 75323 Bad Wildbad

Gemeinschaftspraxis  
Dr. Dr. (Univ. Prag) Rezutka und Kollegen  
Rotebühlplatz 19  
70178 Stuttgart



Anerkanntes MS-Zentrum  
der DMSG

Prof. Dr. med. Peter Flachenecker  
Chefarzt

Sekretariat  
Büro: 07081 173-202/-257  
Fax: 07081 173-215  
Zentrale: 07081 173-0  
E-Mail: [quellenhof.chefarztsekretariat@sana.de](mailto:quellenhof.chefarztsekretariat@sana.de)

Cağlar Erdi Yalcin  
Stationsarzt  
Station 2

Bad Wildbad, 23.06.25 yc

## Vorläufiger Abschlussbericht

Sehr geehrte Kollegen,

wir berichten über

**Herrn Banduliak, Andrii, \* 13.03.1989,  
Tunzhofer Str. 12, 70191 Stuttgart,**

der sich vom **04.06.2025** bis zum **24.06.2025** zur stationären neurologischen Rehabilitationsbehandlung in unserer Fachklinik befand.

|                                   |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diagnosen:</b>                 | Meningoenzephalitis und Meningomyelitis durch EBV-Infektion am 10.07.2018                                                                                                                        |
| <b>Funktionsstörungen:</b>        | Beinbetonte spastische Tetraparese<br>Rumpfinstabilität<br>Erhöhte Erschöpfbarkeit ("Fatigue")<br>Kognitive Einschränkungen<br>Depressive Stimmungslage                                          |
| <b>Aktivitätseinschränkungen:</b> | Aufgehobenes Steh- und Gehvermögen<br>Rollstuhlpflichtigkeit<br>Grob- und Feinmotorikstörung<br>Schwierigkeiten beim beidhändigen Hantieren<br>Mangelnde Ausdauerleistung<br>Minderbelastbarkeit |

### **Anamnese:**

Herr Banduliak kommt zum zweiten Aufenthalt in unsere Fachklinik, zuletzt befand er sich von 07.02.2024 bis zum 12.03.2024 zur stationären neurologischen Rehabilitationsbehandlung in unserer Fachklinik. Die Diagnose einer Meningoenzephalitis durch EBV-Infektion am 10.07.2018 wurde in der Ukraine festgestellt. Die ausführliche Anamnese war wegen einer Sprachbarriere nicht möglich. Der Patient spricht nur Ukrainisch und Englisch. Den mitge-

brachten Unterlagen ist zu entnehmen, dass der Patient im Juli 2018 eine Meningoenzephalitis mit EBV-Infektion entwickelt hatte. Im Verlauf sei es zu einem Multiorganversagen gekommen, der Patient wurde intubationspflichtig und in ein künstliches Koma versetzt. Auf der Intensivstation entwickelte Herr Banduliak ein Mendelsohn-Syndrom mit gastrointestinaler Blutung. Im Verlauf wurde er an die ECMO angeschlossen und über mehrere Wochen ungefähr 60 Tage auf der Intensivstation behandelt. Nach der Stabilisierung des Zustandes konnte der Patient wieder extubiert werden, ferner entwickelte der Patient eine Pneumonie mit Pneumothorax rechts sowie eine subtotale Atelektase in der rechten Lunge mit einem kleinen Hydrothorax. Nach der ersten Rehabilitationsbehandlung in der Ukraine habe sich sein Zustand leicht stabilisiert und gebessert. Zur Verbesserung der motorischen Fähigkeiten und Bearbeitung der physischen Belastung wurde eine stationäre Rehabilitationsmaßnahme vom behandelnden Arzt angeregt.

#### Jetzige Beschwerden und funktionelle Einschränkungen

Bei der Aufnahme beklagte der Patient Rückenschmerzen und Fußschmerzen. Bei dem Patienten sei Gehen und Stehen aktuell nicht möglich, jedoch schafft er den Transfer selbstständig, beinbetonte spastische Tetraparese mit Rumpfinstabilität, Fatigue, Muskelschmerzen, ein bis zwei Schritte mit Stöcken möglich, leichte Konzentrationsstörungen.

#### Vegetative Anamnese

Appetit gut, Durst normal, Trinkmenge 2-3 Liter täglich, Stuhlgang normal, Wasser lassen normal, aber er habe nächtlichen Harndrang und Inkontinenz. Keine Schlafstörungen. Pollenallergie bekannt, er rauche ca. 20 Zigaretten am Tag, er trinke keinen Alkohol.

#### Medikation/Therapien bei Aufnahme

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Carbimazol 5 mg | 1-0-0       |
| Spasmex 45 mg   | 1/3-1/3-1/3 |
| Vitamin B 12    | 1-0-0       |

Physiotherapie 2x pro Woche.

#### Vorerkrankungen

Er leide an Hyperthyreose. Er sei inkontinent. Z.n. Multiorganversagen im Juli 2018, degenerative Veränderungen der WS.

#### Familienanamnese

Keine relevanten Erkrankungen zu eruieren.

#### Arbeits- und Sozialanamnese

Seit der Einwanderung nach Deutschland im Juli 2023 arbeitete er in ein paar Projekte bezüglich Cloud Security. Zudem sucht er über die Arbeitsagentur eine neue Stelle. Flucht der Ukraine wegen des Krieges, er war in der Ukraine als Rechtsanwalt tätig. Er spricht Ukrainisch und Englisch, keine Rentenleistungen. Herr Banduliak ist ledig, er hat keine Kinder, er lebt alleine in einem Appartement, welches barrierefrei ist. Vorhandene Hilfsmittel sind ein elektrischer Rollstuhl und ein Rollator, Pflegebett, Duschstuhl. Zudem habe er beiderseitige Wadenschienen. Er habe SBA mit GdB 80, Merkzeichen B, G, aG, Pflegegrad 3.

#### **Aufnahmebefunde**

##### Allgemein-klinischer Befund

36 - jähriger, rechtshändiger Patient in reduziertem Allgemein- und normalem Ernährungszustand, Haut und Schleimhäute intakt mit Z.n. Tracheotomie, kardiopulmonaler und abdominaler Untersuchungsbefund unauffällig. Lunge auskultatorisch regelrecht, BWS und LWS klopfschmerzhaft, periphere Pulse seitengleich palpabel, Größe 174 cm, Gewicht 96 kg, keine tastbar vergrößerten Lymphknoten, Nierenlager bds. frei, Bauchdecke weich, kein DS,

keine Resistenzen, Peristaltik normal, Leber und Milz nicht tastbar, Bruchpforten ohne Befund, beiderseits keine Beinödeme.

#### Neurologischer Befund

Kein Meningismus, kein Laségue, kein Kalottenklopfschmerz.

Hirnnerven: Pupillen isokor mit prompter Reaktion auf Licht, keine faziale oder trigeminale Affektion, Gaumensegel hebt sich seitengleich, keine Sprach- oder Sprechstörung, keine Schluckstörung. GF fingerperimetrisch unauffällig, Geruch und Geschmack anamnestisch unauffällig, normale Bulbusstellung, kein Nystagmus, keine Hypästhesie im Gesichtsbereich und mimische Muskulatur unauffällig, Zungenbeweglichkeit unauffällig, keine Dysarthrie, keine Dysphagie.

Motorik: Beinbetonte spastische Tetraparese, Schulteranteversion KG 4/5 bds., Ellenbogenflexion KG 4/5 bds., Fingerflexion 4/5 bds., Hüftflexion 4/5 bds., Knieflexion 3/5 rechts, 3-4/5 links, Fußheber 3/5 rechts und 2/5 links.

Reflexe: Muskeleigenreflexe der oberen und unteren Extremitäten mittellebhaft auslösbar, keine Babinski und kein Fußklonus.

Koordination: Romberg-Stehversuch nicht möglich, kann mit Hilfe gut Aufstehen, Finger-Nase-Versuch bds. ataktisch, Knie-Hacken-Versuch bds. dysmetrisch und ataktisch.

Sensibilität: Keine Angabe von Sensibilitätsstörung zum Aufnahmezeitpunkt.

Neuropsychologisch: Leichte Fatigue sowie verminderte Aufmerksamkeit, Antriebslosigkeit und depressive Stimmung.

#### Psychischer Befund

Wacher, kooperativer und zu allen Qualitäten gut orientierter Patient. Freundlich zugewandt. Stimmungslage ausgeglichen. Keine formalen oder inhaltlichen Denkstörungen. Kein Anhalt für alltagsrelevante kognitive oder mnestiche Defizite.

#### **Ergänzende Diagnostik**

Folgt.

#### **Rehabilitationsverlauf und –ergebnis**

Herr Banduliak kam nach stattgehabter Meningitis mit EBV-Virusinfektion im Juli 2018 mit einer beinbetonten Tetraparese, Rumpfinstabilität, kognitiven Einschränkungen zur stationären neurologischen Rehabilitationsmaßnahme in unsere Fachklinik. Die Rehabilitationsziele betrafen die Stand- und Ganganbahnung mit Ausbau der Gehstrecke, Rumpfstabilisierung, Verbesserung von Feinmotorik, selektiven Fingerbewegungen und den bimanuellen Fertigkeiten, den Ausbau der Ausdauerleistung mit Verbesserung der kognitiven Leistungsfähigkeit. Dementsprechend verordneten wir ein individuell angepasstes Therapieprogramm, bestehend aus Physiotherapie auf neurophysiologischer Grundlage, überwiegend als Einzelbehandlung, aber auch in der Gruppe, Ergotherapie, Musiktherapie, Entspannungstraining, Rollstuhlversorgung sowie Beratung durch unseren Sozialdienst. Daneben klärten wir ausführlich in Form von Vorträgen und ärztlichen Einzelberatungen über die Erkrankung auf.

#### Die Therapieberichte folgen im endgültigen Entlassbericht.

Herr Banduliak gab beim Abschlussgespräch an, dass er mit dem Therapieprogramm sehr zufrieden war. Er sagte, dass seine Rückenschmerzen, die vor der Behandlung aufgetreten waren, stark zurückgegangen seien, sich seine Körperhaltung verbessert habe und seine Bein- und Rückenmuskulatur gestärkt worden sei. Außerdem habe sich der Hypästhesie in seinem rechten Fuß verringert. Er gab außerdem an, dass er von den Übungen im Warm- und Kaltwasser Pool sehr profitiert habe. Er erklärte jedoch, dass er die Angst vor Stürzen, die bei seiner Ankunft bestand, nicht überwinden konnte und dass diese weiterhin besteht. Er gab an, dass er in seinen Sitzungen mit dem Psychologen in dieser Hinsicht keine Fort-

schritte machen konnte. Er erklärte, dass nach den Physiotherapieprogrammen seine Ausdauerleistung und Kondition zunahmen und daher das Gefühl der Müdigkeit abnahm. Herr Banduliak nahm kooperativ und motiviert an allen Therapiemaßnahmen teil. Er zeigte sich zufrieden mit dem Therapieprogramm und Rehabilitationsergebnis.

### Sozialmedizinische Epikrise

Folgt.

### Medikation bei Entlassung:

Spasmex 45 mg 1/3-1/3-1/3

Vitamin B 12 1-0-0

*Selbstverständlich können auch andere, evtl. preisgünstigere Präparate mit dem gleichen Wirkstoff verordnet werden*

### Weitere Empfehlungen:

- Weitere ambulante Krankengymnastik auf neurophysiologischer Grundlage.

### Beurteilung der Arbeitsfähigkeit:

- ☐ arbeitsfähig  
☒ arbeitsunfähig  
☐ entfällt (berentet)

### Skalenwerte

|                        | Aufnahme           | Entlassung         |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| Barthel-Index          | 85 von 100 Punkten | 85 von 100 Punkten |
| Frühreha-Barthel-Index |                    |                    |

Wir danken für die Zuweisung und Weiterbetreuung des Patienten und verbleiben

mit kollegialen Grüßen

  
Çağlar Erdi Yalçın  
Stationsarzt

# LABOR ENDERS

Prof. Dr. med. Gisela Enders & Kollegen, MVZ · Medizinische Diagnostik

>Seite 1< Alles

Kumulativbericht vom: 06.06.25 14:30 h

Blatt: 1 / 1

Banduliak, Andrii

geb.: 13.03.1989

|                  |              |           |                |                |
|------------------|--------------|-----------|----------------|----------------|
|                  |              | Abnahme   |                |                |
|                  |              | Eingang   | 08.02.24 10:48 | 05.06.25 11:48 |
|                  |              | Einsender | WBQHN3         | WBQHN2         |
| Verfahren        | Ref. Bereich | Einheit   | 11933410       | 11956331       |
| EILT wg. RefBer. |              |           | durch Labo     |                |
| EDTA-Blut        |              |           |                |                |
| Kl.BB u. Thrombo |              |           |                |                |
| Leukozyten       | 3900-10200   | /µl       | 7290           | 7410           |
| Erythrozyten     | 4.3-5.8      | Mio/µl    | 5.6            | 5.4            |
| Hämoglobin       | 13.5-17.2    | g/dl      | 16.5           | 16.6           |
| Hämatokrit       | 39.5-50.5    | %         | 47.8           | 47.1           |
| MCV              | 80.0-99.0    | fl        | 85.5           | 87.4           |
| RDW              | < 14.5       | %         | 12.3           | 12.3           |
| MCH              | 27.0-33.5    | pg        | 29.5           | 30.8           |
| MCHC             | 31.5-36.0    | g/dl      | 34.5           | 35.2           |
| Thrombozyten     | 150-370      | Tsd./µl   | 279            | 218            |
| Blutsenk. 1 Std. | 0-15         | mm/h      | 2              | 6              |
| Serum aus Gelm.  |              |           |                |                |
| Natrium          | 130-145      | mmol/l    | 143            | 141            |
| Kalium i. S.     | 3.5-5.1      | mmol/l    | 4.1            | 4.5            |
| Calcium i. S.    | 2.20-2.60    | mmol/l    | 2.35           | 2.33           |
| Eisen i. S.      | 59-158       | µg/dl     | 177            |                |
| Ferritin         | 23-290       | µg/l      | 67             |                |
| Vitamin B 12     | 200-1000     | ng/l      | 670            |                |
| 25-OH-Vitamin D  | 20.0-50.0    | µg/l      | 31.9           | 25.2           |
| Kreatinin        | 0.60-1.20    | mg/dl     | 0.93           | 1.18           |
| GFR(CKD)/1,73qm  | siehe unten  | ml/min    | 107            | 79             |
| GFR(MDRD)/1,73qm |              | ml/min    | >60 1)         | >60 1)         |
| Harnstoff        | 13-43        | mg/dl     | 29             | 32             |
| Harnsäure        | 3.4-7.0      | mg/dl     | 5.8            | 6.7            |
| GOT (AST)        | < 50         | U/l       | 32             | 28             |
| GPT (ALT)        | < 50         | U/l       | 93             | 50             |
| γ-GT             | < 60         | U/l       | 64             | 55             |
| AP               | 40-130       | U/l       | 114            | 94             |
| LDH              | < 250        | U/l       | 145            | 162            |
| CK               | 20-200       | U/l       | 74             | 101            |
| Cholesterin      | < 240        | mg/dl     | 203            | 231            |
| Triglyc., gesamt | < 200        | mg/dl     | 225            | 253            |
| HDL-Cholesterin  | > 40         | mg/dl     | 34             | 28             |
| LDL-Cholesterin  | < 160        | mg/dl     | 136            | 147            |
| Chol/HDL Quot.   | < 4.5        |           | 6.0            | 8.2            |
| CRP              | < 5.0        | mg/l      | 0.6            | 5.6            |
| SD.-Diagn.       |              |           |                | s. Beurtei 2)  |

Kumulativbericht vom: 06.06.25 14:30 h

Blatt: 1 / 2

Banduliak, Andrii

geb.: 13.03.1989

|                  |              | Abnahme   |                |                |  |  |  |  |  |
|------------------|--------------|-----------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|
|                  |              | Eingang   | 08.02.24 10:48 | 05.06.25 11:48 |  |  |  |  |  |
|                  |              | Einsender | WBQHN3         | WBQHN2         |  |  |  |  |  |
| Verfahren        | Ref. Bereich | Einheit   | 11933410       | 11956331       |  |  |  |  |  |
| TSH basal        | 0.40-4.00    | mU/l      | <0.01 2)       | 0.19           |  |  |  |  |  |
| FT3              | 2.70-4.30    | ng/l      | 7.90           | 3.23           |  |  |  |  |  |
| FT4              | 10.1-16.5    | ng/l      | 30.4           | 13.3           |  |  |  |  |  |
| GlucoseExact     |              |           |                |                |  |  |  |  |  |
| BZ nüchtern      | 60-99        | mg/dl     | 94             | 84             |  |  |  |  |  |
| Urin             |              |           |                |                |  |  |  |  |  |
| Spez. Gewicht    | 1.001-1.035  |           | 1.020          |                |  |  |  |  |  |
| Glucose i.U.qua. | < 50         | mg/dl     | neg            |                |  |  |  |  |  |

|                  |         |          |         |               |  |  |  |  |  |
|------------------|---------|----------|---------|---------------|--|--|--|--|--|
| Urinstatus       |         |          |         | n.durchgef 3) |  |  |  |  |  |
| Reaktion: pH     | 5.0-8.0 |          | 5.0     |               |  |  |  |  |  |
| Eiweiss im Urin  | < 120   | mg/l     | neg     |               |  |  |  |  |  |
| Urobilinogen     | neg     | mg/dl    | neg     |               |  |  |  |  |  |
| Bilirubin i.U.   | neg     |          | neg     |               |  |  |  |  |  |
| Ketonkörper      | neg     | mg/dl    | neg     |               |  |  |  |  |  |
| Nitrit           | neg     |          | neg     |               |  |  |  |  |  |
| Erythrozyt. i.U. | neg     |          | neg     |               |  |  |  |  |  |
| Leukozyten i.U.  | neg     |          | pos     |               |  |  |  |  |  |
| Urinsediment     |         |          |         |               |  |  |  |  |  |
| Erythrozyten     | 0-1     | /Blickf. | 0-1     |               |  |  |  |  |  |
| Leukozyten       | negativ | /Blickf. | 2-5     |               |  |  |  |  |  |
| Plattenepithel   | negativ | /Blickf. | 1-2     |               |  |  |  |  |  |
| Bakterien        | negativ |          | negativ |               |  |  |  |  |  |
| Kristalle        | negativ |          | negativ |               |  |  |  |  |  |

Kommentar zu Auftrag 11933410 vom 08.02.24 10:48 Uhr 1) Aufgrund der relativen Unschärfe der MDRD-Formel bei Kreatinin-Spieg

Kommentar zu Auftrag 11956331 vom 05.06.25 11:48 Uhr 1) Aufgrund der relativen Unschärfe der MDRD-Formel bei Kreatinin-Spieg

ACHTUNG: Diese Art der Befundübermittlung dient der schnellen Bereitstellung von Messwerten - diese können sich im Verlauf der Bearbeitung noch Rechtlich bindend bzw. verwertbar ist ausschließlich der technisch freigegebene und fachlich validierte Befund!

© Labor Enders - Prof. Dr. med. Gisela Enders & Kollegen, MVZ GbR

© 1998-2010 by **medat** GmbH